

Что из перечисленного не относится к опасностям раны: {

- ~ кровотечение
 - = развитие подфасциальной гематомы
 - ~ шок
 - ~ развитие инфекции
 - ~ возможное нарушение целостности жизненно важных органов
- }

Какие из перечисленных относятся к местным симптомам ран: {

- = боль, зияние, кровотечение
 - ~ зыбление
 - ~ эвентрация
 - ~ расхождение краев
 - ~ малигнизация
- }

Интенсивность боли в ране зависит от: {

- ~ количества нервных элементов в зоне повреждения
 - ~ реактивности организма пострадавшего
 - ~ нервно-психического состояния
 - = возраста и пола
 - ~ характера ранящего оружия и быстроты нанесения травмы
- }

Интенсивность кровотечения из раны более всего зависит от: {

- ~ состояния гемодинамики
 - = характера, количества поврежденных сосудов
 - ~ вида ранящего орудия
 - ~ степени инфицированности раны
 - ~ иммунобиологического состояния организма
- }

Наибольшим зиянием отличаются раны: {

- ~ расположенные вдоль лангеровских линий и мышц
 - = расположенные поперек лангеровских линий и мышц
 - ~ расположенные в косом направлении к лангеровским линиям и мышцам
 - ~ расположенные независимо к этим линиям и мышцам
 - ~ операционные раны
- }

Особенностью колотых ран является: {

- ~ зияние раны
- ~ выраженные боли
- = глубина при небольшом повреждении покровов
- ~ кровоточивость

~ быстрое заживление раны
}

Наибольшая опасность повреждения внутренних органов бывает при: {

~ рубленых
~ ушибленных ранах
~ укушенных ранах
= колотых ранах
~ резаных ранах
}

Наиболее благоприятные условия для заживления ран отмечаются при: {

~ огнестрельных ранах
~ отравленных ранах
= резаных ранах
~ укушенных ранах
~ колотых ранах
}

Ровные края и небольшое количество разрушенных тканей характерны для: {

~ колотой раны
= резаной раны
~ рубленой раны
~ скальпированной раны
~ рваной раны
}

Наибольшее разрушение тканей характерны для: {

~ операционных ран
~ ушибленных ран
~ скальпированных ран
= огнестрельных и размозженных ран
~ отравленных ран
}

Выделите местные клинические признаки раневого процесса в фазе воспаления (гидротации): {

~ отсутствие боли в ране
= выраженный отек, гиперемия окружающих рану тканей, обильное гнойное отделяемое
~ скудное серозное отделяемое
~ отсутствие отека стенок раны

}

По отношению к полостям различают раны: {

- ~ слепые
 - ~ радиальные
 - ~ сквозные
 - = проникающие с повреждением и без повреждения внутренних органов
 - ~ касательные
- }

Первичное инфицирование ран возникает: {

- ~ при нарушении асептики
 - ~ при нарушении антисептики
 - ~ при снижении иммунореактивности организма
 - = при попадании инфекции в рану в момент повреждения
 - ~ при последующем лечении
- }

Назовите в какие сроки появляются клинические признаки нагноения ран: {

- ~ на 8-9 сутки
 - ~ через 2 недели
 - = на 2-3 сутки с момента ранения
 - ~ на первый день после ранения
 - ~ через 3 недели
- }

Какие условия необходимы для заживления раны первичным натяжением: {

- ~ небольшие размеры раны
 - = отсутствие инфекции и плотное соприкосновение краев раны
 - ~ проведение антибактериальной терапии
 - ~ широкое зияние раны
 - ~ создание достаточного оттока из раны
- }

Назовите причины вторичной инфекции раны: {

- ~ попадание инфекции в момент ранения
 - = инфицирование в процессе лечения раны
 - ~ появление воспалительной реакции после заживления раны
 - ~ инфицирование при повторных повреждениях
 - ~ инфицирование после выписки больного из стационара
- }

Назовите особенности колотых ран: {

- ~ обильное кровотечение
- ~ зияние краев раны
- ~
- = возможность повреждения внутренних органов
- ~ незначительная глубина повреждения
- ~ малая степень инфицированности
- }

Укажите особенности огнестрельных ран: {

- ~ ровные края повреждения
- = наличие зоны парабиоза, высокий риск развития инфекции
- ~ наличие зоны кровоизлияния
- ~ ограниченность повреждения
- ~ малый риск развития инфекции
- }

Какая рана считается асептической {

- ~ рана в области головы
- ~ рана в области лица
- ~ всякая случайная рана
- ~ рана нанесенная огнестрельным оружием
- = операционная рана
- }

Что препятствует заживлению раны первичным натяжением? {

- ~ наличие фибрина в ране
- = наличие инфекции
- ~ отсутствие дренажа в ране
- ~ большие размеры ран
- ~ сообщение раневого канала с полостью сустава
- }

Вторичное инфицирование раны является результатом: {

- = нарушения правил асептики в процессе ПХО и последующего лечения
- ~ повреждения полых органов
- ~ повреждения паренхиматозных органов
- ~ обширной раневой поверхности
- ~ обильного кровотечения из раны
- }

Микрофлора в случайных ранах начинает размножаться спустя: {

- ~ 3-6 часов
- = 6-12 часов
- ~ 12-24 часов
- ~ 24-48 часов
- ~ 48-72 часов

}

Первая фаза раневого процесса называется: {

- ~ фаза дегидратации
 - ~ фаза альтерации
 - = фаза гидратации
 - ~ фаза пролиферации
 - ~ фаза адаптации
- }

Вторая фаза раневого процесса называется: {

- ~ фаза интоксикации
 - ~ фаза активизации
 - ~ фаза гидратации
 - = фаза дегидратации
 - ~ фаза альтерации
- }

На быстроту и полноценность заживления ран наибольшим образом влияют:

- ~ размеры раны
 - ~ глубина раны
 - = хорошее кровоснабжение и сохранившаяся иннервация
 - ~ возраст больного
 - ~ пол больного
- }

Грануляционная ткань состоит из: {

- = молодых соединительных клеток
 - ~ молодых эпителиальных клеток
 - ~ остеобластов
 - ~ лимфоцитов
 - ~ макрофагов
- }

Какой из перечисленных видов местного лечения применяют при случайных ранах? {

- ~ туалет раны с использованием антисептиков
 - ~ дренирование раны
 - ~ гипсовые повязки
 - ~ вторичная обработка раны
 - = первичная хирургическая обработка раны
- }

Первый слой грануляционной ткани называется: {

- ~ слой горизонтальных фибробластов
- = поверхностный лейкоцитарно-некротический слой

- ~ слой сосудистых петель
- ~ слой вертикальных сосудов
- ~ созревающий слой

}

Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны означает: {

- ~ вскрытие гнойных затеков
- ~ дренирование гнойных затеков
- = иссечение краев, стенок, дна раны, гемостаз послойное ушивание раны
- ~ наложение швов на рану после ее промывания
- ~ наложение первичных швов без предварительной работы в ране

}

К травмированию и разрушению грануляционной ткани может привести: {

- = наложение сухой асептической повязки
- ~ наложение мажевой повязки
- ~ промывание раны
- ~ применение эмульсий
- ~ орошение раны

}

Осколочные раны отличаются: {

- ~ небольшими размерами
- ~ анатомической локализацией
- = значительными размерами и неправильной формой
- ~ незначительной инфицированностью
- ~ нарушением функции жизненно важных органов

}

Раннюю ПХО раны выполняют от момента ранения: {

- = до 24 часов
- ~ до 24-48 часов
- ~ до 48-72 часов
- ~ спустя 72 часа
- ~ через 2 недели

}

Выполнение ПХО раны противопоказано при: {

- ~ кровотечении
- ~ ВИЧ – инфекции
- ~ наличии в ране пули или осколка
- = шоке
- ~ проникающем характере раны

}

К особенностям ПХО (перв. хир. обр.) ран лица относится: {

- ~ наложение редких швов
- ~ наложение отсроченных швов
- ~ широкое рассечение раны
- ~ тщательное дренирование ран
- = экономное иссечение тканей, наложении ранних первичных швов
- }

В объем первой помощи при ранах не входит: {

- ~ обработки кожи вокруг раны растворами антисептиков
- ~ наложение асептической повязки
- = наложение первичных швов
- ~ введение анальгетиков
- ~ транспортировка больного
- }

Противопоказанием к ПХО раны является: {

- ~ сквозное ранение
- ~ проникающее ранение
- ~ наличие в ране крупных сосудов
- = развитие гнойной инфекции
- ~ расположение раны вблизи жизненно-важных органов
- }

Назовите основной элемент местного лечения случайной раны: {

- ~ обезболивание
- ~ применение гипсовой повязки
- ~ применение антибиотиков
- ~ дренирование раны
- = выполнение ПХО раны
- }

Первично-отсроченный шов накладывается после ПХО раны: {

- ~ сразу после операции
- ~ в ближайшие сутки
- = через 3-5 суток
- ~ через 6-8 суток
- ~ через 9-10 суток
- }

Первичные швы на свежеинфицированную рану накладываются: {

- = сразу после ПХО раны
- ~ через 2-3 суток после ПХО раны
- ~ через 3-7 суток
- ~ после появления в ране грануляций
- ~ соблюдение сроков не имеет значения
- }

Какой шов можно наложить для вторичного закрытия раны, если с момента ранения прошло 18 дней: {

- ~ первичный шов
- ~ первично-отсроченный
- ~ ранний вторичный
- = поздний вторичный
- ~ не накладывается

Для фазы гидратации характерно: {

- = отек, гиперемия тканей с обильным гнойным отделяемым
- ~ наличие фибринозных наслоений на дне раны
- ~ отсутствие местной температуры
- ~ появление грануляций
- ~ развитие рубцовой ткани

Для фазы дегидратации характерно: {

- ~ гиперемия тканей
- ~ обильное отделяемое из раны
- ~ воспалительный отек тканей
- = очищение раны и появление грануляций
- ~ лихорадка

Для лечения гнойной раны в фазе гидратации применяют: {

- ~ асептические повязки
- ~ повязки с мазью
- ~ наложение вторичных швов
- ~ сближение краев раны лейкопластырем
- = повязки с гипертоническим и антисептическими растворами, ферментами, антибиотиками

Быстрейшему очищению раны в I фазу раневого процесса способствует: {

- ~ применение физиологического раствора
- ~ создание покоя пораженному участку
- ~ применение асептических повязок
- = применение протеолитических ферментов
- ~ применение мазевых повязок

Для лечения гнойной раны в фазе дегидратации показано: {

- = редкие перевязки с наложением мазевых повязок
- ~ частые перевязки с применением гипертонических растворов

- ~ промывание раны протеолитическими ферментами
 - ~ наложение первично-отсроченных швов
 - ~ наложение третичных швов
- }

Профилактическая доза противостолбнячной сыворотки составляет: {

- ~ 1500 АЕ
 - = 3000 АЕ
 - ~ 10000 АЕ
 - ~ 15.000 АЕ
 - ~ 30.000 АЕ
- }

Профилактическая доза противогангренозной сыворотки составляет: {

- = антиперфрингенс - 10.000 АЕ , антиэдематиненс - 10.000 АЕ
 - антивибрион септикус - 10.000 АЕ
 - ~ антиперфрингенс - 10000 АЕ , антиэдематиненс - 15.000 АЕ
 - антигистолитикус - 15.000 АЕ
 - ~ антиперфрингенс - 10.000 АЕ , антиэдематиненс - 10.000 АЕ
 - антивибрион септикус - 10.000 МЕ, антигистолитикус - 10.000 МЕ
 - ~ антиперфрингенс - 3.000 АЕ, антиэдематиненс - 30.000 АЕ
 - антивибрион септикус - 3.000 АЕ
 - ~ антигистолитикус 1500 АЕ, антиперфрингенс - 10000 АЕ
 - антиэдематиненс - 5000 АЕ
- }

Какой способ лечения ран является правильным, если у больного свежее инфицированная рана, на дне которой видны подколенная артерия и вена?

- ~ иссечение стенок и дна раны вместе с подколенными сосудами с наложением сосудистого шва и зашиванием раны
 - ~ первичная хирургическая обработка не производится, рана лечится консервативно
 - = иссечение краев раны, не трогая подколенные сосуды, введение антибиотиков в рану и зашивание ее
 - ~ рассечение раны, дренирование раневого канала
 - ~ усиленное консервативное лечение и после появления грануляций зашивание раны
- }

Тампонада раны производится с целью: {

- ~ улучшение оттока раневого экссудата
 - ~ уменьшения отека тканей
 - ~ профилактики нагноения
 - = остановки кровотечения
 - ~ уменьшение болей
- }

Гнойно-резорбтивная лихорадка характеризуется: {

- = высокой температурой
 - ~ относительно удовлетворительным состоянием больного
 - ~ постоянной бактериемией
 - ~ раной со скудным серозно-гнойным отделяемым
 - ~ петехиальной сыпью
- }

Для первичного заживления раны в первую очередь необходимо: {

- ~ дренирование раны
 - ~ частое промывание раны
 - ~ наличие в ране кровяных сгустков
 - = плотное соприкосновение краев раны
 - ~ антибиотикотерапия
- }